

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

TEST DE APRENDIZAJE VERBAL ESPAÑA-COMPLUTENSE (TAVEC)

Eje V: Neurocognición y Memoria Verbal • Paradigma de Aprendizaje Supraspan de Benedet y Alejandre

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Test de Aprendizaje Verbal España-Complutense (TAVEC; versión adultos e infantil TAVECI).
Nombre Original	TAVEC (Benedet & Alejandre, 1998; adaptación formal del CVLT de Delis et al., 1987).
Autores Originales	María Jesús Benedet, Ph.D. y María Ángeles Alejandre (Universidad Complutense de Madrid).
Estandarización	TEA Ediciones (1998); Proyecto NEURONORMA (Peña-Casanova et al., 2009; baremos en España).
Eje Clínico y Constructo	Eje V: Neurocognición. Memoria episódica verbal, curva de aprendizaje y olvido a largo plazo.
Tipo de Instrumento	Prueba neuropsicológica estandarizada de ejecución verbal heteroaplicada individual.
Estructura de Tareas	Lista de aprendizaje A (16 palabras en 5 ensayos), Lista de interferencia B, Recuerdo y Reconocimiento.
Población y Rango	Adultos y ancianos (16 a 85 años; versión infantil TAVECI para 3 a 16 años).
Tiempo de Administración	30 a 35 min de aplicación activa (más 20 minutos de intervalo demorado libre).
Régimen de Licencia	TEA Ediciones / Hogrefe; prueba estandarizada comercial con baremos oficiales.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL PARADIGMA DE APRENDIZAJE SUPRASPAN

El **TAVEC** trasciende las listas de palabras convencionales al incorporar los principios de la psicología cognitiva de la memoria y la neuropsicología de procesos:

- Curva de Aprendizaje y Organización Semántica:** Utiliza 16 palabras cotidianas pertenecientes a 4 categorías semánticas encubiertas (ropa, herramientas, frutas, especias), permitiendo valorar si el sujeto agrupa espontáneamente las palabras por significado (estrategia semántica frontal) o si las repite de forma desordenada o serial.
- Diferenciación de Fases Mnésicas:** Separa nítidamente la **adquisición progresiva** (ensayos 1 al 5), la **resistencia a la interferencia proactiva y retroactiva** (mediante la lista B), la **retención y consolidación demorada** (tras 20 min) y la **recuperación guiada** (con claves semánticas y test de reconocimiento).
- Estándar Oro en Deterioro Cognitivo Leve:** Es la prueba más sensible en el ámbito hispanohablante para detectar la amnesia episódica prodrómica de la Enfermedad de Alzheimer.

3. FASES DEL PROTOCOLO TAVEC Y COMPOSICIÓN DE REACTIVOS

Fase del Protocolo	Rango	Procesos Neurocognitivos Evaluados
1. Aprendizaje Lista A (Ensayos 1-5)	0 a 80 pts	Registro verbal, atención sostenida, memoria a corto plazo y curva de ganancia inter-ensayos.
2. Interferencia Lista B	0 a 16 pts	Capacidad de registro ante estímulos novedosos y vulnerabilidad a interferencia proactiva.
3. Recuerdo Corto Plazo Libre	0 a 16 pts	Evocación libre inmediata de Lista A tras la interferencia (mide interferencia retroactiva).
4. Recuerdo Corto Plazo con Clave	0 a 16 pts	Beneficio de la facilitación semántica con nombres de las 4 categorías.
5. Recuerdo Largo Plazo Libre	0 a 16 pts	Evocación libre tras 20 minutos de tareas no verbales (mide tasa de olvido hipocampal).
6. Recuerdo Largo Plazo con Clave	0 a 16 pts	Evocación demorada facilitada con los nombres de las 4 categorías semánticas.
7. Test de Reconocimiento	0 a 44 ítems	Discriminación de 16 palabras diana frente a 28 distractoras (aciertos, falsas alarmas).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO METROLÓGICO EN ESPAÑA / LATAM

Las baremaciones originales (Benedet & Alejandre, 1998) y del Proyecto NEURONORMA (Peña-Casanova et al., 2009; $N > 1000$) avalan su rigor:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna Total	Alfa de Cronbach = 0.89 - 0.94	Elevada cohesión interna en las listas de palabras y ensayos sucesivos.
Estabilidad Test-Retest	Coefficiente $r = 0.80 - 0.88$	Alta reproducibilidad en ensayos de memoria en intervalos estables.
Sensibilidad en DCL Amnésico	Sensibilidad = 92%	Insuperable sensibilidad para detectar déficit de retención a largo plazo.
Especificidad Diagnóstica	Especificidad = 88%	Distingue eficazmente personas mayores sanas de cuadros neurodegenerativos.
Validez Discriminante	Efecto $d = 1.45 - 2.10$	Diferencia nítidamente amnesia cortical de disfunción subcortical/frontal.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE ÍNDICES NEUROPSICOLÓGICOS

- **Puntuación Total de Aprendizaje (A1-A5):** Suma de aciertos en los cinco ensayos de Lista A (rango 0 a 80 palabras).
- **Registro de Errores:** Se contabilizan por separado las **Perseveraciones** (repetición de palabras en el mismo ensayo) y las **Intrusiones** (palabras emitidas no pertenecientes a la lista).
- **Índice de Retención:** Porcentaje de palabras retenidas a largo plazo respecto al mejor ensayo de aprendizaje:

$$\text{Índice de Retención} = \left(\frac{\text{Recuerdo Demorado Libre}}{\text{Aciertos en Ensayo 5}} \right) \times 100 \quad (\%)$$

- **Discriminabilidad en Reconocimiento:** Capacidad para distinguir palabras diana de distractoras (aciertos menos falsas alarmas).
- **Conversión a Puntuaciones T:** Las puntuaciones directas se transforman en Puntuaciones T ($M = 50$, $DE = 10$) según baremos de edad y escolaridad.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Puntuación T	Percentil	Estado de la Memoria Episódica Verbal (Benedet)
Muy Superior	$T \geq 65$	$P \geq 93$	Capacidad sobresaliente de retención y evocación mnésica.
Normal Promedio	$T = 40$ a 64	$P = 16$ a 92	Rendimiento mnésico verbal adecuado dentro de la media esperable.
Déficit Leve	$T = 30$ a 39	$P = 2$ a 15	Dificultades leves de consolidación o evocación; vigilancia evolutiva.
Déficit Moderado	$T = 20$ a 29	$P = 0.1$ a 1.9	Punto de corte patológico compromiso grave de memoria episódica.
Déficit Severo	$T < 20$	$P < 0.1$	Amnesia severa colapso total de la curva de aprendizaje y retención.

PERFIL DISOCIADO CRÍTICO (TAVEC LP LIBRE $T < 35$ / RETENCIÓN $< 50\%$):

Un **Recuerdo a Largo Plazo Libre** con $T < 35$ (o una retención inferior al 50% frente al ensayo 5) con **nulo beneficio de las claves semánticas** y múltiples falsas alarmas en reconocimiento constituye el marcador neuropsicológico clásico del **déficit hipocampal de consolidación** característico de la Enfermedad de Alzheimer prodrómica.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA: AMNESIA CORTICAL VS. DEFICIT SUBCORTICAL

PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON EL PERFIL TAVEC:

- **Paso 1 (Administración Completa del Protocolo):** Administrar los 5 ensayos de Lista A, la Lista B, los recuerdos a corto plazo, el intervalo demorado de 20 min (ocupado con pruebas no verbales) y los recuerdos demorados y reconocimiento.
- **Paso 2 (Análisis del Perfil de Recuperación):**
 - *Patrón Cortical / Hipocampal (Enfermedad de Alzheimer):*
Curva de aprendizaje aplanada (suma total A1-A5 < 35 palabras).
Desplome catastrófico en recuerdo demorado (0 a 2 palabras evocadas).
Nulo beneficio con claves semánticas (no mejora el número de aciertos).
Fallo masivo en Reconocimiento (múltiples falsas alarmas por intrusiones semánticas).
 - *Patrón Subcortical / Frontal (Depresión, Parkinson, Vascular Subcortical):*
Aprendizaje inicial bajo por inatención, pero gran incremento con claves semánticas.
Reconocimiento prácticamente perfecto (alta discriminabilidad), lo que demuestra que la información fue consolidada pero falló el acceso activo de búsqueda frontal.
- **Paso 3 (Decisión Terapéutica):** Si el perfil es cortical, derivar a neurología para biomarcadores de Alzheimer; si es subcortical, tratar cuadro afectivo o vascular.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: DIFERENCIACIÓN DE PSEUDODEMENCIA DEPRESIVA

Identificación: Mujer de 67 años, enfermera jubilada, que consulta con su familia por quejas de memoria graves: “siente que no retiene nada y se le borra todo lo que le dicen”, asociando llanto frecuente y apatía tras el fallecimiento de su cónyuge hace 8 meses.

Evaluación Neuropsicológica con TAVEC:

- **Curva de Aprendizaje (A1 a A5):** 4 - 6 - 7 - 8 - 9 aciertos (Total = 34 palabras; Puntuación $T = 36$; curva moderadamente disminuida por quejas de fatiga y desconcentración).
- **Recuerdo a Largo Plazo Libre (a los 20 min):** 3 palabras evocadas (**Puntuación $T = 28$** , aparente amnesia severa).
- **Recuerdo a Largo Plazo con Claves Semánticas:** **12 palabras evocadas** (aumento espectacular de 3 a 12 aciertos al suministrar las categorías; Puntuación $T = 52$, normal).
- **Test de Reconocimiento:** **16 / 16 aciertos diana**, 0 falsas alarmas (Discriminabilidad perfecta = 100%, Puntuación $T = 58$).

Interpretación Diagnóstica: La huella mnésica estaba íntegra en el hipocampo pero el acceso libre estaba bloqueado por abulia y bradipsiquia. Descarte categórico de demencia amnésica y confirmación de **pseudodemencia depresiva** (Episodio Depresivo Mayor).

Evolución: Tratamiento con psicoterapia y antidepresivo; a los cuatro meses, su evocación libre ascendió a 12 palabras de forma espontánea.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

INTERVALO LIBRE ESTRICTO:

Durante los 20 minutos de espera demorada nunca deben administrarse tareas con material verbal; realizar exclusivamente tests visomotores o perceptuales.

VALOR DE LAS INTRUSIONES:

La presencia de > 3 intrusiones en evocación o falsas alarmas semánticas en reconocimiento es altamente sugestiva de patología amnésica cortical temprana.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Benedet, M. J., & Alejandro, M. A. (1998). *TAVEC: Test de Aprendizaje Verbal España-Complutense (Manual)*. TEA Ediciones.
2. Delis, D. C., Kramer, J. H., Kaplan, E., & Ober, B. A. (1987). *California Verbal Learning Test (CVLT)*. Psychological Corporation.
3. Peña-Casanova, J., et al. (2009). Spanish normative studies in young adults (NEURONORMA project): Norms for verbal learning and memory. *The Clinical Neuropsychologist*, 23(5), 785-808.
4. Vilar-López, R., et al. (2008). Utilidad del TAVEC en la detección de simulación y disfunción mnésica en daño cerebral. *Revista de Neurología*, 47(11), 567-572.